認識異位性皮膚炎

蔡宗儒醫師 編撰

1. 什麼是異位性皮膚炎（異膚）？是怎麼造成的？

異位性皮膚炎是一種慢性且會反覆發作的過敏性皮膚疾病，常與遺傳有關，是嬰幼兒最常見的皮膚疾病之一，約占小兒人口的 3～5%，其中 60% 的患者會在一歲內發病，隨著年紀漸增大多也隨之改善。除了皮膚會出現乾燥搔癢之外，有時會合併不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液、結痂或苔癬化等。異膚的成因與基因遺傳、免疫反應、以及環境誘發三大因素相互作用而導致皮膚屏障功能受損。

健康的皮膚最外層有一層皮脂膜，底下的角質細胞排得很緊密，能擋住過敏原和細菌，也把水分鎖在皮膚裡。異膚孩子的角質層之間有縫隙，水分容易散失，皮膚就變乾；過敏原和微生物也比較容易鑽進去，引來免疫細胞發炎，刺激皮膚裡負責癢覺的神經，孩子就會一直抓，越抓皮膚越破。所以保濕要天天做，發炎的時候再用醫師開的藥膏控制。

2. 異位性皮膚炎要如何診斷？

異膚診斷以臨床表現為主。診斷標準依 Hanifin-Rajka 準則，符合三項或以上即可診斷。

- 皮膚搔癢
- 典型的皮膚症狀（濕疹樣皮膚炎或苔癬化皮膚炎）及位置
- 慢性持續性或反覆發作皮膚炎超過 6 個月以上
- 個人或家族成員有異位性體質，如過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎或蕁麻疹等

3. 異位性皮膚炎要如何保護？

異位性皮膚炎的預防及保護中，「清潔」及「保濕」是最重要的。

- 清潔：一天一次，不可只用清水洗（應選用「非皂類」清潔產品）。
- 保濕：一天至少兩次，其中一次建議在洗完澡稍微擦拭後，還殘留部分濕氣時進行。（應選用「乳霜」潤膚劑，可有效增加皮膚角質層的含水力，幫助修復皮膚屏障功能。規律使用潤膚劑能夠減低藥膏的使用量及症狀嚴重程度。）

4. 異位性皮膚炎注意事項

- 出門帶濕、乾毛巾，用濕毛巾隨時擦口水、汗水（汗水會刺激皮膚導致抓癢）；不可用濕紙巾。
- 室溫維持 22～24℃、濕度維持 50～60%。
- 洗澡時間少於 15 分鐘，水溫低於 40℃。

5. 沐浴乳、乳液、乳霜怎麼挑？

1. 劑型越油，保濕越久。由強到弱是軟膏、乳霜、乳液；乳液含水多、很快就乾，異膚的孩子建議選乳霜。
2. 選無香料、無色素、不含酒精的產品。標示「無香味」不一定沒加香料，看成分表裡沒有「香料、香精、fragrance、parfum」比較準。
3. 含精油或植物萃取的產品，對皮膚屏障受損的孩子可能是刺激來源。
4. 含尿素、果酸、水楊酸的產品，擦在發炎或破皮的地方會刺痛，嬰幼兒先不要用。
5. 新產品先在手臂內側小範圍擦 2～3 天，沒有變紅、變癢再全身使用。

擦了以後刺痛、變紅或更癢，先停用，回診時把產品帶來給醫師看。

6. 皮膚變粗、變紅時，在家怎麼處理？

> 以下做法適用於已經由醫師看過、手邊有醫師開立藥膏的孩子。還沒看過診、或不確定該用哪一支藥膏，請先回診。

整片皮膚變粗糙或紅紅的

1. 先用濕毛巾擦掉口水和汗水，再擦乳液。
2. 悶熱流汗時，把室溫調低、除濕。
3. 這樣做 3 天沒有改善，或第一天就開始抓，請開始擦醫師開的藥膏，每天早晚各一次。

單顆紅疹（蚊蟲咬或不明原因）

- 不用等，直接用棉棒沾醫師開的藥膏點在紅疹上，一天 3 次，臉上的紅疹也用同一支藥膏。
- 這顆紅疹的位置不擦乳液，其他地方照常保濕。

類固醇藥膏擦了兩週還沒有完全好，請提早回診，不要自己一直擦下去。

7. 異位性皮膚炎要如何治療？類固醇藥膏怎麼擦、怎麼減量？

- 口服：抗組織胺、抗生素、類固醇
- 外用：類固醇類藥膏（TCSs）、局部免疫調節藥膏（TCIs）（醫立妥：3 個月以上嬰兒）

【擦藥膏方式：藥膏應該油油亮亮的覆蓋上去（薄薄來回搓抹是錯誤擦法）】

常用類固醇藥膏依等級分成 7 級，應依醫師評估皮膚狀況，決定適合的藥膏種類及使用期間，錯誤的使用方式不但達不到治療效果，更會增加不必要副作用產生。

紅疹退了，藥膏不要一下子全停，突然停藥容易再發。醫師會依下表分階段往下調；每一階段擦多久、用哪一支藥膏，以醫師填寫的為準，回診時再由醫師決定要不要往下一階段。臉和身體的皮膚厚度不同，藥膏與時程分開排。耳朵、頭皮、脖子請照「身體」那一支擦，這幾處也最容易漏擦。

部位	期間（醫師填寫）	擦法
臉	＿＿/＿＿ ~ ＿＿/＿＿	每天早晚擦（＿＿＿＿＿＿）
	＿＿/＿＿ ~ ＿＿/＿＿	週二、四、六擦（＿＿＿＿＿＿）＋週一、三、五擦醫立妥
	＿＿/＿＿ ~ ＿＿/＿＿	週六、日擦（＿＿＿＿＿＿）＋週一、三、五擦醫立妥
身體（含耳朵、頭皮、脖子）	＿＿/＿＿ ~ ＿＿/＿＿	每天早晚擦（＿＿＿＿＿＿）
	＿＿/＿＿ ~ ＿＿/＿＿	週二、四、六擦（＿＿＿＿＿＿）＋週一、三、五擦醫立妥
	＿＿/＿＿ ~ ＿＿/＿＿	週六、日擦（＿＿＿＿＿＿）＋週一、三、五擦醫立妥

8. 什麼時候該回診或就醫？

1. 疑似皮膚感染：患部流膿、滲液變多、結黃色痂皮、紅腫熱痛加劇，或突然冒出成群小水泡並快速擴散
2. 合併發燒，或孩子活力明顯變差
3. 癢到明顯影響睡眠或日常活動，做好保濕並依指示用藥後仍未改善
4. 疹子範圍快速擴大或短期內反覆發作

用藥的調整（換藥、停藥、增量）請回診與醫師討論，勿自行決定。本院為門診、非急診；高燒不退、意識不清等危急狀況請逕赴急診或撥 119。

～～～早期預防，早期治療～別讓過敏誤了您的孩子～蔡宗儒醫師 關心您的健康～～～